

Viidatud allikad

- Valma, K., Surva, L., Hääl, H. (2014). Lepitusmenetlus perevaidlustes. *Juridica*, I, 86–103. www.lepitus.ee/docs/juridica.pdf. (25.04.2017).
- Kelly, Joan B. (2004). Family Mediation Research: Is There Empirical Support for the Field? (An Update). *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1–2), 3–36, Fall-Winter. http://www.mediate.com/pdf/Family_Mediation_Research_Is_There_Empirical_Support_for_the_Field_.pdf. (25.04.2017).

Perelepitusest saate rohkem lugeda ja kutseliste lepitajate kontaktid leiate Eesti Perelepitajate Ühingu kodulehel www.lepitus.ee.

Koos kainema ja tervema Eesti poole



Jane Alop

Ekspert, Tervise Arengu Instituut

Viimased sotsiaalvaldkonda puudutavad uudised on murettekitavad. Probleemiks pole mitte ainult see, et ei jätku ressursse teenuste arendamiseks, vaid raha on puudu ka seadusega ettenähtud hoolekandeteenuste pakkumiseks. Sellises olukorras rääkida teenustest inimestele, kelle elu juhib alkohol, on poliitiline enesetapp. Nii arvab siiski ainult lühinägelik profaan. Alkoholi liigtarvitamine mõjutab tänapäeval absoluutselt iga ühiskonnaliikme elu ja õnnelikud on need, kes on ohustatud ainult kaudselt.

Eestlastel on kombeks juua palju ja juua ennast purju. Uuringud kinnitavad, et üks kolmandik täiskasvanud eestlastest on alkoholi liigtarvitajad¹ (Rehm jt 2012), sealhulgas neist ligikaudu kümnendikul on alkoholi tarvitamise häire, mis hõlmab alkoholi

kuritarvitamist ja sõltuvust. Ligikaudu sada tuhat inimest põeb kergemal või raskemal kujul haigust, millega kaasneb palju füüsilisi ja psüühilisi tervisehäireid ning mitmesuguseid sotsiaalseid probleeme. Selliseid inimesi on rohkem kui meie kaitseväes ajateenistuse käigus väljaõpetatud reservväelasi, keda on 60 000 (Riigikaitse arengukava 2013–2022).

Alkoholi liigtarvitamisega kaasnevate kahjude vähendamiseks peab riik aktiivset võitlust laial rindejoonel ja selle lahingu nimi on huvide konflikt. Tõendus põhised soovitused ühiskonnas alkoholi liigtarvitamise vähendamiseks rõhutavad erinevate meetmete – alkoholi nähtavuse ja kättesaadavuse piiramise, liigtarvitamise varajase avastamise ja tõendus põhise sõltuvusravi kättesaadavuse parandamise – üheaegse

¹ Alkoholi liigtarvitamiseks loetakse, kui naine tarvitab üle 8 ja mees üle 16 ühiku nädalas või korraga enam kui 6 ühikut. Üks ühik on 10 g puhast alkoholi. Vt lisa www.alkoinfo.ee.

rakendamise vajalikkust.

Kuna Eesti alkoholi tarvitamise ja sellega seotud kahjude näitajad on märkimisväärselt halvemad Euroopa keskmistest (Orro jt 2016), käivitati 2014. aastal Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega programm „Kainem ja tervem Eesti”², mille eesmärgid on alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine, ravi kättesaadavuse tagamine ja alkoholi liigtarvitamist puudutava teadlikkuse suurendamine. Programmi peamine sihtgrupp on tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kel spetsialistidena on kõige paremad võimalused oma patsiente ja kliente abistades neid eesmärkide saavutada.

Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine

Erinevalt näiteks vähkkasvajatest ei pea alkoholi liigtarvitamise varajaseks avastamiseks olema arst ega tegema kalleid uuringuid. Piisab, kui kasutada Maailma Terviseorganisatsiooni heaks kiidetud AUDIT (ingl *Alcohol Use Disorder Identification Test*) enesehinnangulist testi, mis on kõigile veebist kättesaadav³. Mõne minutiga saab teada, kas inimese alkoholitarvitamise harjumused suurendavad tema riski haigestuda. Teadusuuringute kohaselt on alkoholi tarvitamisel otsene seos 60 haiguse tekkimisega ja ligi 200 haiguse tekkepõhjusena loetakse muu hulgas ka alkoholi liigtarvitamist (Ravijuhendite nõukoda 2015). Seega alkoholi liigtarvitamise sõelumine pole vähem oluline kui ükskõik millise teise tervisehäire – kasvaja, veresoonkonna haigus jt – varajane avastamine.

Esmatasandi teenusepakkujad – perearst, pereõde, samuti ka sotsiaalvaldkonna töötajad – on need, kes professionaalse pilguga

juba varakult probleeme märkavad ja saavad vajadusel oma erialaseid oskuseid kasutades asjaosaliste tähelepanu sellele juhtida. Emotsionaalse moraali lugemise asemel peab spetsialist suutma ratsionaalse lähenemisega tõsta patsiendi/kliendi teadlikkust olukorrast ja selgitada talle ohumärkide seotust tema alkoholitarvitamise harjumustega. Kainuse propageerimise kõrval räägitakse üha enam mõõdukast alkoholi tarvitamisest ja motiveeriva intervjuerimisena tuntud tehnikaid kasutades meenutatakse inimesele, et oma tervise eest vastutab ta ise. Inimeste vähese teadlikkuse ja kalduvuse tõttu eitada alkoholi mõju enda elule on ülioluline, et professionaal võtaks selle teema alati jutuks, kui räägitakse inimese tervisest, sotsiaalsest toimetulekust või elukvaliteedist tervikuna. Programm „Kainem ja tervem Eesti” pakub taolise lühisekkumise koolitusi alkoholiteema konstruktiivseks käsitlemiseks perearsti/pereõde lühikese vastuvõtu käigus. Sotsiaalvaldkonna töötajatele tutvustatakse meetodit infopäeval⁴.

Alkoholitarvitamise häire

AUDIT test sobib ainult alkoholi liigtarvitamise sõelumiseks, alkoholisõltuvuse diagnoosi saab siiski määrata ainult arst. Tänapäeval soovitatakse häbimärgistamise vähendamiseks kasutada mõistet „alkoholitarvitamise häire”, kuid alkoholi kuritarvitaja ja alkoholisõltlase kliiniline käsitlus on erinev. Kuritarvitajad üldjuhul eitavad oma alkoholi tarvitamisest tingitud probleeme, nimetades neid „ajutisteks raskusteks”. Kuritarvitajate puhul on efektiivne lühisekkumine, seda tuleb teha kindla regulaarsusega, ja alles siis, kui soovitud tulemust ei saavutata, tuleks

² Lisainfo programmi kohta www.tai.ee/et/kainem-ja-tervem-eesti, küsimuste korral võib pöörduda kte@tai.ee.

³ Eestikeelne test on allalaetav leheküljel www.tai.ee/images/KTE/audit_EST.pdf.

⁴ Esimene infopäev toimus 12. mail Tallinnas, lisainfo tulevaste infopäevade kohta maria.ratassep@tai.ee.

kaaluda intensiivsemat ravisekkumist.

Kui inimesel on tekkinud psühholoogiiline, halvemal juhul ka keemiline sõltuvus alkoholist, on esimeseks ülesandeks motiveerida teda ravile pöörduma. Seda võivad takistada siiski mitmed asjaolud, millest üks on madal enesehinnang ja vähene usk paranemise võimalikkusesse. Lisaks on haigus väga stigmatiseeritud ja nii haigel kui ka tema lähedastel on suur häbitunne. Samuti kardetakse, et konfidentsiaalsus ei ole tagatud ja ravile pöördunu võib näiteks kaotada töö. Ebapiisavad on ka teadmised ravi põhimõtetest ja arvatakse, et need ei ole erinevatel põhjustel vastuvõetavad, näiteks ei soovita alkoholist täielikult loobuda. Ravile pöördumisega kaasnevad hirmud on loomulikud ja seetõttu ei tohiks kunagi kasutada ravile saatmiseks mingeid sunnimeetodeid, välja arvatud juhul, kui inimene on eluohtlik iseendale või teistele⁵. Abivajaja võib võtta pikalt hoogu ja panna sellega lähedaste kannatuse tõsiselt proovile. Paljude sõltlaste lähedastel tekib kaassõltuvus, mis võib samuti vajada professionaali abi.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti” raames on koostatud ravijuhend, mille soovitustest lähtudes pakub alkoholitarvitamise häirega inimestele (sõltlastele, aga ka vähema intensiivsusega sekkumisest abi mitte saanud kuritarvitajatele) raviteenuseid viis pädevuskeskust (kontaktid leiab lk 64). Kuna ravi on pikaajaline ja nõuab patsiendilt väga suurte muutuste tegemist, siis on kõige olulisem patsiendi enda motivatsioon. Kogu raviprotsess ongi peamiselt joomise vähendamise või kaine olemise õppimine individuaalselt ja rühmas läbiviidava nõustamise põhjal, millele vajadusel lisatakse ravimid.

Alkoholi kuritarvitamine ja sõltuvus võivad olla nii põhjus kui ka tagajärg toimetuleku-

probleemide tekkimisel. Seetõttu kaasatakse patsiendi nõusolekul raviprotsessi ka tema lähedased. Keskkond ei ole siiski mitte ainult kodu ja sageli vajavad suhteprobleemide kõrval klaarimist ka palju maisemad asjad: võlad, tööpuudus jm. Selleks et tagasilöögid, näiteks tööotsingutel, ei põhjustaks tagasilangust, kaasatakse alkoholisõltuvuse diagnoosiga patsiendi raviprotsessi kohe ka sotsiaaltöötajad. Haigla juhtumikorraldaja ülesanne on luua side kohaliku omavalitsuse spetsialistidega ja kaasata nad võimalikult varakult. Tänapäeva sõltuvusravi toimub peamiselt ambulatoorselt ja see võimaldab inimese tasakaalukat taasintegreerimist kogukonda. Üksikutel juhtudel, enamasti siis, kui patsiendil puudub täielikult toetav lähedaste inimeste võrgustik, võib osutuda efektiivsemaks „täiesti uus algus” koos keskkonna vahetusega⁶.

Sotsiaalvaldkonna töötaja võimalused kahjusid vähendada

Igaüks, kes on kokku puutunud alkoholi kuritarvitaja või alkoholisõltlasega, on kogenud abituse ja lootusetuse tunnet. Isegi kui on helgemaid päevi, ei jätku neid sageli kauaks ja tagasilangusest põhjustatud masendus on veelgi suurem. Sotsiaaltöö tegijate eelisvõrreldes lähedastega on see, et nad ei ole liigtarvitajaga emotsionaalselt seotud ning neil on vajalikud teadmised ja oskused demagoogilisest sõnasõjast hoidumiseks.

Alkoholi liigtarvitamise märkamine ja sellest asjatundlikult inimesega rääkimine on sotsiaaltöötaja ülesanne sama iseenesestmõistetavalt, nagu see on perearsti ja pereõe ülesanne. AUDIT testi ja lühisekkumise meetod võimaldab spetsialistil käsitleda teemat kliendile vastuvõetaval ja ajalisel

⁵ Tahtest olenematu ravi tingimused on kehtestatud psühhiaatrilise abi seadusega.

⁶ Eestis pakub sellist võimalust Lootuse Küla www.lootusekula.ee.

tõhusal viisil. Kui sellise vestluse tulemusena tekib inimesel valmisolek oma probleemiga tegeleda, on see juba suur töövõit. Sotsiaaltöötajast võib olla suur abi inimesele ja ka tema lähedastele ravivõimaluste tutvustamisel ja hirmude vähendamisel.

Sotsiaaltöötaja peaks inimest julgustama ravile pöörduma, kuid ta ei tohiks ise ravi-asutuse poole pöördumisega võtta inimeselt vastutust, kui puudub vastav kokkulepe abivajajaga. Spetsialisti ülesanne on abistada inimest selle otsuseni jõudmisel, mitte otsustada tema eest.

Alkoholisõltuvus on krooniline ajuhaigus, mille ravi on pikk protsess, kuhu panustavad erinevate valdkondade spetsialistid nii ravi-

asutuse sees kui ka sellest väljaspool. Nende koostöö sujuvusest sõltub nii ravitulemus kui ka töötajate endi kurnatus. Ravivajaduse ja raviplaani paneb paika arst. Ravimeeskond – õed, psühholoogid, tegevusterapeutid ja sotsiaaltöötajad – on selle elluviija. Ravi alustanud patsientidelt võetakse muu hulgas nõusolek selleks, et vajadusel kaasatakse raviprotsessi kohalik sotsiaaltöötaja, et tagada kogukonna toetus. Tartu linn on suurepäraseks näiteks, kus omavalitsus ja haigla teevad head koostööd.

Kõige suurem vastutus ravi käigu ja tulemuse eest on ikkagi inimesel, kuid sellega hakkama saamiseks vajab ta turvalist keskkonda ja toetavat kogukonda. **S**

Viidatud allikad

- Orro, E. Martens, K., Lepane, L., Josing, M., Reiman, M., Ahermaa, E.** (2016). Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2016. Tallinn: Tervise Arengu Instituut. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/148110851999_Alkoholi%20aastaraamat%202016_.pdf (26.04.2017).
- Rehm, J., Shield, K., Rehm, M., Gmel, G., Frick, U.** (2012). Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential gains from effective interventions for alcohol dependence. Kanada: Centre for Addiction and Mental Health. https://amphoraproject.net/w2box/data/AMPHORA%20Reports/CAMH_Alcohol_Report_Europe_2012.pdf (26.04.2017).
- Ravijuhendite nõukoda** (2015). Alkoholitervitamise häirega patsiendi käsitus, RJ-F/7.1-2015. <http://ravijuhend.ee/downloader.php?file=guide-682-doctypetext27> (26.04.2017).
- Riigikaitse arengukava 2013–2022.** www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/riigikaitse-arengukava/index.html (26.04.2017).

Programmi „Kainem ja tervem Eesti” raames pakuvad tasuta raviteenust viis haiglat. Ravi pakutakse nii ravikindlustusega kui ka -kindlustuseta inimestele. Järgnevalt on toodud kontaktid alkoholitarvitamise häire raviteenusele registreerumiseks.

Lõuna-Eesti Haigla

tel 786 8569 (E–R 8.00–17.00) või e-postil registratuur@leh.ee

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

tel 617 2582 (E–R 8.30–17.00) või e-postil kte@regionaalhaigla.ee

Pärnu Haigla

tel 447 3296 (E–R 8.00–16.00) või e-postil helen.saluri@ph.ee

Tartu Ülikooli Kliinikum

tel 731 9100 (E–R 7.30–18.00) või internetis www.kliinikum.ee/eriarsti-vastuvott/registreerumine

Viljandi Haigla

tel 5866 5160 (E–R 8.00–16.00) või e-postil alko@vmh.ee

Märka, motiveeri ja toeta



Meida Griin

sotsiaaltöötaja, TÜ Kliinikum,
programmi „Kainem ja tervem Eesti” Tartu meeskonna liige

- Lapsevanem jätab oma alaealise lapse üksinda koju ja läheb ise sõpradega pidu pidama. Pidu venib arvatust pikemaks ja laps ununeb sootuks.
- Ema joob lapse juuresolekul järjest mitmeid päevi. Laps otsib naabritelt abi, sest põrandal lamav ema ei reageeri lapse püüetele teda äratada. Sekkuvad lastekaitse ja politsei.
- Politsei edastab omavalitsusele korduvalt teateid kontrollida kodust olukorda ja sekkuda: 50ndates aastates töötu poeg terroriseerib oma ema, et saada talt pensionipäeval raha alkoholi ostmiseks. Ema ei tee politseile avaldust vägivalda kohta, sest kardab, et sellest muutub olukord veel hullemaks.
- Elukaaslaste lõbus ühine alkoholipruukimine lõpeb lööminguga ja politsei kutsumisega. Kaineks saades lepitakse kuni järgmise korran.
- Psüühilise erivajadusega mees viibib periooditi tahtevastasel ravil ja kohtumääruse alusel ööpäevaringsel erihooldusel, ravi tulemusel ja kontrollitud keskkonnas viibides saab ta oma eluga hästi hakkama. Koju naastes hakkab aga taas alkoholi tarvitama ja muutub siis vägivaldseks, lõhub kaaskodanike vara, varastab poest asju. Lühikesed kodus elamise perioodid vahelduvad hoolekandeesutuses viibimisega. Tema eestkostjaks on omavalitsus, sest omaksed on ammu loobunud suhtlemisest.
- Kerge vaimse alaarenguga kolmekümnendates mees elab varjupaigas ja käib poe ees möödujalt raha nurumas. Milleks see raha kulub, pole raske mõistatada, pidevalt tema käes olev õllepudel räägib ise enda eest. Kunagi õppis see mees ameti, kunagi oli tal korter.

Need on ainult üksikud näited kümnetest, millega sotsiaaltöötajad ja lastekaitse spetsialistid nii kohalikes omavalitsustes kui hoolekandeesutustes iga päev kokku puutuvad. Tihti on nendel lugudel üks ühine tunnus: need on arenenud liiga kaugele, sõltuvus ja sellega kaasnevad probleemid on jõudnud sellisesse järku, kust situatsiooni tagasikerimine ei ole enam võimalik. Tervis, toimetulekuoskused või suhted on pöördumatult rikutud.

Inimesed kirjeldavad sotsiaaltöötajatele oma probleeme nagu töö kaotamine, majanduslik kitsikus, raskused elukoha leidmisel, pere- ja sõprussuhete katkemine, süvenevad

terviseprobleemid, depressioon. Nad ootavad ja otsivad lahendusi. Nad väidavad, et alkoholi tarvitamine sai alguse probleemidest, et alkohol aitas mured unustada, muutis korraks seltskondlikumaks, leevendas stressi ja võttis valu. Paraku aetakse segamini põhjus ja tagajärg: alkohol on see, mis toob kaasa probleemide lumepalli.

Mida saab teha sotsiaaltöötaja või mõni teine alkoholi liigtarvitajaga kokku puutuv inimene? Ennekõike saab ta kahjustavat käitumist võimalikult vara märgata, sellele tähelepanu pöörata ja aidata leida tee ravini enne, kui raviga alustada võib olla juba liiga

hilja. Selles protsessis on oluline märksõna motivatsioon, selle üles leidmine ja toetamine. Näen oma praeguses töös küllalt palju inimesi, kelle eest astuvad ravi saamiseks samme omaksed või erinevad ametkonnad. See kõik jääb tulutuks, kui inimesel endal pole motivatsiooni olukorda muuta. Kui inimene on oma riskikäitumise teadvustanud ja astunud esimesed sammud muutuste suunas, vajab ta pikal paranemise teekonnal tuge. Seda pakub talle ravimeeskond, kuid oluline on ka igapäevase sotsiaalse keskkonna toetus. Kui lähisuhted on katkenud ja hooliv ning kainust toetav võrgustik puudub, on eriti oluline tugiisiku kasutamise võimalus. Kõrvuti raviga tuleb hakata lahendama juba tekkinud sotsiaalseid probleeme: töö, elukoht,

suhted, majanduslik toimetulek jne. Parim tulemus saavutatakse inimese enda, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajate, erinevate tugisüsteemide ja ravimeeskonna koostöös.

Pikka aega on sotsiaalsüsteemis üritatud lahendada inimeste alkoholi liigtarvitamisega kaasnevaid probleeme, kuid võimalused raviks on olnud väga piiratud. Praegu viies Eesti suuremas linnas toimiv programm „Kainem ja tervem Eesti” on andnud võimaluse tegelda probleemide algpõhjusega ja saada ravi ka juhul, kui ravikindlustus puudub. Julgustan kõiki spetsialiste, kes oma töös puutuvad kokku alkoholi liigtarvitajatega, kasutama seda võimalust inimeste aitamiseks. Hoolivus algab märkamisest ja sisaldab nii julgustamist kui toetust. **S**